

■ 心不全／心臓リハビリ

急性心不全56万人、心リハ実施で院内死亡のオッズ0.39～0.49倍

日本の全国データJROAD-DPC(2012～2023年)・ADLは3日前後の開始が最良

院内死亡はどの開始時期の群も心リハなし群より低かった。退院時のバーセル指数は1日以内～5日の群で3.2～3.8点高く、6日以上群では差が小さかった。

開始日との関係を曲線で見ると、死亡が最も低いのは6.1日、機能面が最も良いのは3.3日で、指標によって「良い時期」が異なった。不死時間バイ

アスの感度分析でも死亡の結果は一貫した。

観察研究のため、心リハを受けられる状態の人ほど予後が良いという偏りは残る。バーセル指数の差も3～4点と小さい。著者らは前向き研究での確認が必要としている。



ADLを狙うなら入院早期から、死亡は幅広い時期で低い

出典 [Journal of the American Heart Association](#) ↗

数字で見る

564,830人

急性心不全の入院患者(全国DPC)

0.39～0.49倍

心リハ群の院内死亡の調整オッズ比

3.3日

機能面が最も良好だった開始時期

■ 診療報酬／回復期リハ病棟

回復期リハ病棟入院料2・3・4、経過措置が9月30日で終了

10月以降も算定するには、別添7と様式49・様式49の2を10月14日(水)必着で届け出る。土日を含む提供体制と実績指数の確認が要る。



出典 [PT-OT-ST.NET\(厚生局の案内\)](#) ↗

■ 歩行評価／ウェアラブル

生活の場の歩行計測、脳卒中は6報217人のみでメタ解析できず

パーキンソン病の歩行速度は0.84m/秒(95%CI 0.77～0.91)だが、研究間のばらつきが極めて大きい。著者らは脳卒中を「決定的に未整備」とし、測り方の標準化を求めた。



出典 [JMIR](#) ↗

短 信

〈介護保険〉介護2割負担の拡大、利用控えの検証求める

介護保険部会。単身の所得基準280万→230～260万円案、影響は約35万人の推計 出典 [PT-OT-ST.NET](#) ↗

〈養成教育〉PT卒前コアカリ、10項目に再編

日本理学療法教育学会。新設はIT活用・チームワーク・学修とりフレクションの3項目 出典 [POST](#) ↗

〈心臓リハビリ〉心リハの男女差、最大の壁は「紹介」

46コホート100万人超のSR。紹介率は女性57.8%・男性67.2%、紹介後は差が縮小 出典 [Catheter Cardiovasc Interv](#) ↗

〈脳卒中／デジタル〉高齢脳卒中患者のデジタル忌避、支援で低く

上海の343人。eヘルスリテラシーと周囲の支援が高いほどテクノフォビアが低い 出典 [JMIR](#) ↗

〈パーキンソン病〉歩き始めは専用の練習で第1歩が伸びる

10人のクロスオーバー予備研究。連続歩行の訓練では第1歩に変化なし 出典 [J Neurol Phys Ther](#) ↗

〈腰痛／運動〉慢性腰痛の運動、最適量は定まらず

239試験の用量反応NMA。短期は週3～4回で改善、84%が高バイアスで確実性は低 出典 [Br J Sports Med](#) ↗

〈脊髄損傷〉脊損後のオピオイド、急性期の常用が尾を引く

豪州の質的研究23人。回復期・地域へ持ち越され、かかりつけ医に負担が集中 出典 [Disabil Rehabil](#) ↗

〈糖尿病／脳卒中〉GLP-1薬で脳卒中リスク半減と関連

スウェーデン糖尿病登録17万人超の観察研究。全脳卒中49%低下、因果は未確定 出典 [Medical Tribune](#) ↗